

ACEis/ARBs

ชื่อยา	ขนาดเริ่มต้น (มก./วัน)	ขนาดสูงสุด (มก./วัน)	การปรับยาในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ACE inhibitors			
Enalapril*	5	40	CrCl $\leq$ 30 มล./นาที: ลดขนาดยาเริ่มต้น 2.5 มก.
Lisinopril	10	40	CrCl 10-30 มล./นาที: ลดขนาดยาเริ่มต้นร้อยละ 50 CrCl < 10 มล./นาที: ลดขนาดยาเริ่มต้นเหลือ 2.5 มก.
Perindopril arginine	5	10	CrCl < 30 มล./นาที: ลดขนาดยาเริ่มต้นเหลือ 2.5 มก.
Ramipril	2.5	20	CrCl < 40 มก./นาที ลดขนาดยาเริ่มต้นเหลือ 12.5 มก.
ARBs			
Azilsartan	20 – 80	80	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา
Candesartan	16	32	CrCl $\leq$ 30 มล./นาที: AUC และ Cmax เพิ่มขึ้น 2 เท่า
Fimasartan	60	120	CrCl $\leq$ 30 มล./นาที: ลดขนาดยาเริ่มต้น 30 มก.
Irbesartan	150	150 - 300	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา
Losartan*	25 - 50	100	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา
Olmесartan	20	40	CrCl < 40 มล./นาที: ไม่ต้องปรับขนาดยาเริ่มต้น CrCl < 20 มล./นาที: AUC เพิ่มขึ้น 3 เท่า
Telmisartan	40	80	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา
Valsartan	80	320	CrCl < 30 มล./นาที: ไม่มีข้อมูลการปรับขนาดยา ใช้ด้วยความระมัดระวัง

*ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Adapted from Thai CKD 2022.

ACEIs/ARBs

การตรวจติดตาม Cr, K ภายใน 2 – 4 สัปดาห์ หลังเริ่มหรือปรับเพิ่มขนาด ACEI/ARB

การตรวจติดตาม	ผลเลือด	การจัดการ	
		สาเหตุ	ACEIs/ARBs
Creatinine	↑Cr < 30%	-	สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึงขนาดสูงสุด
	↑Cr 30-50%	สาเหตุอื่นเสมอ - Volume depletion/Heart failure NSAIDs/herb - Renal artery stenosis	ลดขนาดยาลง 50% (ถ้ายังไม่พบสาเหตุอื่น) และพิจารณาเพิ่มขนาดได้ ถ้า Cr ลดลงแล้ว
	↑Cr > 50%	*พบน้อยมาก - พิจารณาตรวจ doppler U/S renal artery เฉพาะผู้ที่มีข้อบ่งชี้ของการทำ angioplasty เช่น heart failure และ rapidly progressive eGFR decline เป็นต้น	หยุดยาไปก่อน (ถ้ายังไม่พบสาเหตุอื่น) และพิจารณาเริ่มใหม่ขนาดต่ำได้ ถ้า Cr ลดลงแล้ว
Potassium	K > 5.5 mEq/L	ควรหาสาเหตุอื่น NSAIDs, ผักผลไม้ที่มี K สูง แก้ไข - จำกัดอาหารและยาข้างต้น - Diuretic (furosemide/thiazides), K binders	ไม่ปรับขนาดยาหรือหยุดยา (ยกเว้น...ถ้า K ≥ 6.0 mEq/L ให้หยุดยาชั่วคราว และรักษาเพื่อลดระดับ K ก่อน หลังจากนั้นพิจารณาเริ่มยาใหม่ได้หลังควบคุมระดับ K < 5.0 mEq/L แล้ว)